Prescription infirmière et mise en œuvre sécurisée

UE B.3 · Domaine B · CM du 22/10/2026, 13 h 30–15 h 30 (planning de promotion).
VERSION PROVISOIRE — synthèse de travail à confronter au CM de Mme Tison.

Objectifs du cours : Distinguer exécution d'une prescription, rôle propre et prescription infirmière dans son champ légal. · Vérifier la cohérence et la sécurité avant la mise en œuvre d'un traitement. · Savoir suspendre la mise en œuvre en cas de doute, demander clarification, surveiller et tracer.

Cours détaillé et repères cliniques

1. Distinguer les cadres

Sur prescription : l'IDE met en œuvre les actes/soins qui relèvent d'une prescription selon les textes, après vérification de la prescription, de la situation et de la sécurité. L'existence d'une prescription ne supprime pas le jugement professionnel : devant un risque ou une incohérence, l'IDE demande clarification et sécurise la personne.

Rôle propre : l'IDE identifie les besoins, formule les diagnostics infirmiers relevant de son champ, fixe des objectifs, organise et réalise les soins autonomes prévus par le Code, surveille et évalue. Un protocole de soins infirmiers peut guider certaines situations; il doit être conforme aux règles applicables et connu de l'équipe.

Prescription infirmière : ce n'est pas un pouvoir général comparable à celui d'un médecin. Elle est limitée aux actes, produits de santé ou examens énumérés par les textes et à leurs conditions/modalités. L'arrêté du 26 juin 2026 fixe notamment les listes applicables; il faut consulter la version officielle en vigueur et vérifier les conditions professionnelles (formation, déclaration ou protocole, selon le cas).

Le référentiel de formation 2026 inscrit l'apprentissage des principes de prescription dans le cursus, avec des acquis progressifs. En 1re année, l'étudiant comprend les responsabilités et s'entraîne au contrôle sous supervision; il n'a pas de droit propre de prescription. En stage, il agit dans les limites du statut d'étudiant et de l'encadrement.

Trois questions sont à distinguer : qui décide du traitement ou de l'examen? Qui est autorisé à le prescrire dans ce cadre? Qui peut le réaliser, avec quelles vérifications et sous quelle responsabilité? « Prescription infirmière » désigne un champ défini par les textes et leurs conditions; cela ne signifie ni que tout IDE peut prescrire tout produit, ni qu'un étudiant le peut. Consulter les articles et arrêtés consolidés en vigueur à la date concernée.

Les mentions nécessaires varient selon le support, le médicament, le dispositif, l'examen et les textes. L'ordre doit être assez clair pour identifier la personne, le produit ou l'acte, les modalités nécessaires et le prescripteur habilité. Si une information manque ou paraît contradictoire, la faire clarifier par son auteur ou le professionnel prévu par le circuit. Ne pas modifier silencieusement une prescription ni compléter une donnée incertaine par habitude.

La responsabilité ne se réduit pas à « suivre l'ordonnance ». Le professionnel qui met en œuvre vérifie la cohérence avec l'état observé, ses compétences, les allergies connues et les règles applicables. L'étudiant apprend à repérer les incohérences, à expliquer son doute et à solliciter l'encadrant; il agit sous encadrement et selon les actes autorisés par son statut.

2. Vérifier avant d'agir

Contrôler la prescription : identité et concordance dossier/bracelet selon procédure; date, auteur habilité, lisibilité, indication, médicament ou dispositif, forme, dose et unité, voie, horaire/fréquence, durée et conditions particulières. Les exigences exactes varient selon l'acte et le produit.

Contrôler le patient et le produit : allergies et réactions antérieures; contre-indications et paramètres utiles; nom, concentration, forme, intégrité, péremption et conservation. Vérifier les dilutions, compatibilités, vitesse/débit si concernés, ainsi que le matériel et la voie d'administration.

Calculer sans précipitation : convertir les unités avant l'opération; écrire la formule et les unités; vérifier que le résultat correspond à une dose ou un débit plausible; contrôler la concentration réellement disponible et le volume à administrer. Pour les médicaments à risque, calcul indépendant par une seconde personne selon procédure; une calculatrice ne remplace pas le contrôle clinique.

Le mémo des « bons » (bon patient, bon produit, bonne dose, bonne voie, bon moment) aide à structurer le contrôle mais n'est pas exhaustif : il faut aussi indication, allergies, intégrité du produit, information, surveillance, traçabilité et conduite en cas d'anomalie.

Une prescription absente, illisible, incomplète, incohérente ou potentiellement dangereuse ne se devine pas : différer l'administration/l'acte si cela peut être fait sans mettre en danger, sécuriser la personne et demander clarification au prescripteur/pharmacien selon le circuit. En urgence, appliquer le protocole et la chaîne d'alerte de l'établissement.

Écrire les données et les unités avant de calculer : dose prescrite (mg) ÷ concentration (mg/mL) = volume (mL); volume total (mL) ÷ durée (h) = débit (mL/h). Convertir avant l'opération (1 g = 1 000 mg; 1 mg = 1 000 microgrammes) et éviter les zéros ambigus. Pour une perfusion par gravité, le débit en gouttes/min dépend du facteur indiqué sur la tubulure : volume (mL) × facteur (gouttes/mL) ÷ durée (min). Vérifier que la convention de l'appareil et du protocole concorde.

Le calcul arithmétique répond à « quelle quantité correspond aux nombres donnés? », pas à « le traitement est-il indiqué et sûr? ». Contrôler ensuite la plausibilité, la concentration réellement disponible, le dispositif de mesure, la voie et les limites individuelles connues. Si le résultat semble inhabituel, refaire le calcul indépendamment et demander vérification selon le protocole plutôt que d'arrondir ou corriger seul.

Réduire les interruptions et les confusions : préparer un patient à la fois si l'organisation le permet, lire l'étiquette au prélèvement et au retour, séparer les préparations, ne pas utiliser un contenant non identifié et écarter une préparation dont l'identité ou la composition n'est plus certaine. Pour les médicaments à risque (par exemple anticoagulants, insuline, opioïdes ou électrolytes concentrés), appliquer les mesures institutionnelles et le double contrôle lorsqu'ils sont prévus; ne pas improviser une règle universelle.

3. Administrer, surveiller, tracer

Avant le geste, informer la personne de ce qui est utile, répondre à ses questions, rechercher son accord dans le cadre applicable, respecter intimité et hygiène/sécurité. Confirmer l'identité au dernier moment selon procédure. Préparer sans interruption évitable et limiter les risques de confusion.

Après administration/acte, surveiller ce qui est pertinent pour le produit et la situation : effet attendu, paramètres cliniques prescrits/protocolisés, réaction allergique ou autre effet indésirable, douleur, conscience, respiration ou signes locaux selon soin. Définir avant le geste qui surveille, quoi, quand et quelle conduite appliquer.

En cas d'erreur ou d'événement indésirable : protéger le patient immédiatement, alerter selon la gravité et la procédure, appliquer les soins urgents nécessaires, conserver les informations factuelles et participer à la déclaration requise. Ne pas masquer, modifier rétroactivement ni retarder la transmission.

Tracer sans délai : traitement/acte réellement réalisé, date/heure, dose/voie si applicable, contrôles ou paramètres pertinents, non-administration et motif, observations, réponse clinique, incident/alerte et suite donnée. Une mention claire permet à l'équipe de poursuivre le soin et d'éviter une double administration.

Avant l'administration, expliquer les modalités utiles, vérifier la compréhension, laisser la personne poser ses questions et prendre en compte son refus. Ne pas contraindre ni dissimuler un médicament. Rechercher la raison du refus, évaluer le risque d'un report avec l'IDE responsable et le prescripteur, puis tracer les faits, les professionnels informés et la décision. Une urgence clinique suit le circuit local.

Préparer la surveillance avant le geste : effet attendu, délai d'observation, paramètres utiles, effets indésirables à repérer, seuils d'alerte du protocole et personne à prévenir. Si une réaction grave survient, déclencher l'alerte et appliquer la conduite d'urgence du service.

Le compte rendu distingue ce qui était prescrit, ce qui a réellement été fait, ce qui a été observé, ce qui a été transmis et la réponse reçue. Une non-administration, un retard ou un refus ne doivent jamais être enregistrés comme une administration. Toute correction documentaire suit les règles de traçabilité et ne masque pas

l’écriture initiale.

Rôle infirmier, surveillance et alerte

- L’IDE analyse la situation, vérifie la prescription et peut demander clarification lorsqu’elle paraît dangereuse ou incohérente.
- L’IDE prépare, réalise et surveille le soin dans son champ; elle informe, trace les faits et transmet les anomalies selon la procédure.
- L’étudiant réalise uniquement les activités autorisées sous encadrement, explicite ses doutes et ne prescrit pas de façon autonome.

Mini-situation : la dose notée et la concentration disponible ne semblent pas compatibles avec le volume préparé. Tu ne corriges pas l’ordre de mémoire et tu n’administres pas le volume douteux : tu reprends les unités/calculs, sécurises le produit, demandes une clarification au professionnel compétent et traces la décision selon le circuit du service.

Études de cas guidées — observer, raisonner, transmettre

Cas 1 — vérifier un calcul avant préparation

Exercice pédagogique uniquement : un ordre validé indique une dose de 250 mg. La solution disponible contient 100 mg par mL. Quel volume correspond à la dose prescrite ?

Calcul écrit : volume = dose prescrite ÷ concentration = 250 mg ÷ (100 mg/mL) = 2,5 mL. Les mg se simplifient; l’unité restante est bien le mL. Ce calcul arithmétique n’autorise pas à administrer : il faut encore confirmer l’identité, l’ordre complet, la voie, la préparation du produit, l’indication, les allergies, la compatibilité et les contrôles prévus.

Contrôle de plausibilité : vérifier la concentration réellement indiquée sur le contenant et la présentation, l’unité et le volume, la possibilité de mesurer avec le dispositif adapté et les règles du service. Pour un médicament à risque, faire le contrôle indépendant requis. Si un chiffre, une unité ou une concentration diffère, arrêter la préparation et demander clarification avant administration.

Cas 2 — prescription incomplète et information discordante

Situation : l’ordre mentionne un produit et une dose, mais ne précise pas la voie; la personne signale une allergie ancienne au même nom de produit. Le dossier comporte une autre voie dans une note antérieure.

Conduite : ne pas choisir la voie par habitude et ne pas considérer la note ancienne comme une validation. Vérifier l’identité, relire le dossier et le document source, maintenir le produit en attente sans le préparer si cela est possible en sécurité, puis joindre le prescripteur ou le professionnel prévu dans le circuit. Transmettre l’information d’allergie et demander un ordre complet et cohérent. En cas de symptômes allergiques actuels, appliquer la chaîne d’urgence.

Traçabilité : noter le motif de la non-administration ou du report, l’heure, l’interlocuteur contacté, l’information transmise, la réponse reçue, la conduite décidée et la surveillance mise en place. Ne pas modifier rétroactivement la prescription.

Cas 3 — calcul de débit et surveillance

Exercice pédagogique : un volume de 500 mL est prescrit sur 4 heures au pousse-seringue ou à la pompe adaptée. Débit théorique = 500 ÷ 4 = 125 mL/h. L’écriture avec unités montre que mL ÷ h donne mL/h.

Avant mise en œuvre : vérifier que l’ordre est bien complet, que le volume, la durée, la voie et le dispositif concordent et que ce débit correspond aux réglages disponibles. Vérifier la prescription avec la situation clinique et les consignes locales. Ce calcul isolé ne constitue pas une indication thérapeutique.

Après démarrage : contrôler le réglage affiché, la ligne et le point de perfusion, la tolérance et les paramètres attendus selon le produit et le patient. Prévoir quand et par qui le débit sera recontrôlé; tracer le débit réellement posé, l’heure de départ, les contrôles et tout incident.

Cas 4 — identité discordante au moment d’administrer

Situation : le nom porté sur le bracelet ne correspond pas au nom de la prescription affichée sur l’écran. Le produit est préparé et l’horaire semble urgent. Une personne de l’équipe dit qu’il s’agit probablement d’une erreur de dossier.

Conduite immédiate : arrêter le processus avant administration. Ne pas utiliser la chambre, le numéro de lit, l’habitude ou l’affirmation orale comme substitut à l’identitovigilance. Garder le produit à part et l’identifier comme non administré selon le circuit local. Reprendre l’identité avec les identifiants prévus, vérifier la prescription source et prévenir l’IDE responsable; demander la correction par la personne habilitée.

Après clarification : reprendre le contrôle depuis le début, y compris patient, produit, dose, voie et horaire. Si l’horaire est dépassé ou si le report peut avoir un effet clinique, faire décider la suite par le prescripteur selon l’urgence. Tracer le report, la discordance, les interlocuteurs, l’heure et la décision, sans modifier le document à la place de son auteur.

Apprentissage : l’urgence apparente ne justifie pas de réduire les contrôles d’identité. Une pause de sécurité et une clarification rapide préviennent une erreur de patient; la traçabilité rend visible la décision et la suite.

Cas 5 — refus d’un soin ou d’un médicament

Situation : une personne refuse une administration prévue et explique qu’elle ne comprend pas pourquoi elle reçoit ce produit. L’équipe indique qu’il est habituellement donné à cette heure.

Conduite : ne pas contraindre ni dissimuler le produit. Écouter les raisons, vérifier l’identité et l’ordre, expliquer avec des mots adaptés l’objectif connu sans dépasser ses compétences, rechercher douleur, nausée, difficulté de déglutition ou incompréhension et proposer de reprendre l’échange. Respecter la décision dans le cadre légal et institutionnel; solliciter l’IDE référente et le prescripteur pour apprécier les conséquences et convenir de la suite.

Surveillance et trace : noter le soin non réalisé et le motif rapporté sans jugement, les informations données, les professionnels prévenus, la décision et la surveillance prévue. Ne pas enregistrer l’administration comme effectuée et ne pas doubler une dose ultérieure sans nouvelle consigne.

Repères pratiques

Étape	Points à contrôler
1. Patient	Identité, dossier, allergies, situation clinique et accord
2. Prescription	Auteur habilité, lisibilité, date, indication, complétude et cohérence
3. Produit / acte	Nom, forme, concentration, dose et unité, voie, horaire, durée
4. Préparation	Calcul et conversions, compatibilité, péremption, intégrité, débit si besoin
5. Après	Efficacité, effets indésirables, paramètres à surveiller, traçabilité et transmission

À retenir par cœur

- Distinguer rôle propre, acte sur prescription et prescription IDE autorisée par texte.
- Une prescription ne se complète pas par supposition : faire clarifier tout doute.
- Contrôler patient, ordre, produit/acte, modalités, allergies, calculs et surveillance.
- Convertir les unités et vérifier plausibilité, concentration, volume/débit; suivre double contrôle local.
- Étudiant de 1re année : pas de prescription autonome; agir sous encadrement et signaler ses limites.
- Surveiller la réponse et les effets indésirables; tracer ce qui a réellement été fait.
- En cas d’erreur : protéger, alerter rapidement, agir selon procédure et documenter factuellement.

Lexique

Acte sur prescription	Acte infirmier dont la réalisation dépend des conditions prévues par les textes et d’une prescription conforme.
Contre-indication	Situation où un produit ou acte ne doit pas être utilisé, ou exige une précaution particulière.
Iatrogénie	Conséquence indésirable liée à un soin, un médicament ou une organisation des soins.
Prescription	Instruction thérapeutique écrite par un professionnel autorisé, dans son champ légal et selon les règles applicables.
Prescription infirmière	Prescription réalisée par une IDE uniquement dans les domaines et conditions autorisés par les textes.
Protocole	Consignes formalisées encadrant une conduite de soins dans un contexte défini.
Responsabilité professionnelle	Obligation de respecter les compétences, règles et devoirs liés à l’exercice et de répondre de ses actes.
Traçabilité	Enregistrement daté, fiable et utile des soins, contrôles, observations et décisions.
Vigilance	Surveillance organisée visant à repérer et signaler risques ou effets indésirables.
Événement indésirable	Événement lié aux soins ayant causé ou pouvant causer un dommage, nécessitant une réaction et parfois un signalement.

Ressource de cours externe : ouvrir le cours repéré. Les ressources externes sont des supports pédagogiques secondaires; vérifier avec les références ci-dessous et le cours de l’IFSI.
Références : Arrêté du 20 février 2026, référentiel IDE, annexe III · Code de la santé publique, art. R.4311-3 · Arrêté du 26 juin 2026 : produits de santé et examens prescriptibles · Formation professionnelle CHU Bordeaux (complément) · Cours externe de départ (secondaire)

Schéma explicatif de fin de cours

Repères visuels pour relier l’observation, le raisonnement et les actions infirmières.

